

29 - Les Tumeurs Ovariennes - Pr. HAROU

Les tumeurs ovariennes, cours destiné aux étudiants de cinquième année de médecine. Pour ce cours, nous allons adopter le plan suivant. Après une brève introduction, nous allons parler des éléments anatomopathologiques et épidémiologiques.

Nous allons aborder l'étude clinique et paraclinique. Et puis, nous finirons par parler des complications du lent d'extension à certification du cancer de l'Obert, ainsi que le traitement des tumeurs ovariennes, avant de finir par l'évolution à la prognostique. En guise d'introduction, on peut dire que les tumeurs ovariennes représentent des processus prolifératifs des tissus ovariens, qu'ils soient primitifs ou secondaires, bénins ou malins, solides ou kystiques.

Nous excluons de ce cours les kystes ovariens fonctionnels. Il faut savoir que les tumeurs bénignes sont les plus fréquentes, que le cancer ovarien reste rare, mais il est de mauvais pronostic. Le traitement des tumeurs ovariennes est la chirurgie dans la plupart du temps.

Sur le plan anatomopathologique, nous utilisons la classification de l'OMS, qui distingue les tumeurs épithéliales des tumeurs non-épithéliales. Les tumeurs épithéliales étant les plus fréquentes, elles peuvent être bénignes, malines ou borderlines. Parmi ces tumeurs épithéliales, on distingue les tumeurs séreuses, mucineuses, endométrioïdes, acellules claires, les tumeurs de Brunner, les tumeurs mixtes épithéliales, les tumeurs épidermoïdes et finalement les carcinomes indifférenciés.

En ce qui concerne les tumeurs épithéliales de l'ovaire, nous distinguons les tumeurs germinales et les tumeurs décredensexuelles du stromogonadique. Les tumeurs germinales étant représentées par les séminomes, le choriocarcinome, les tumeurs du sinus endodermique, les polyembryomes et les thératomes. Les tumeurs décredensexuelles du stromogonadique sont représentées par les tumeurs de la granulosa, les tumeurs fibro-técale, les tumeurs de sertolilédique ainsi que les gynandroblastomes.

Sur le plan épidémiologique, par rapport à la fréquence du cancer de l'ovaire, en France il y a 4400 nouveaux cas par an responsables de 3200 décès. Le cancer de l'ovaire concerne principalement la femme de plus de 45 ans et il est rare chez la femme jeune. Il constitue la cinquième cause de mortalité chez la femme en France.

Les facteurs de risque du cancer de l'ovaire sont représentés par des facteurs hormonaux tels que la nulliparité, l'infertilité et l'âge tardif de la première grossesse. Des facteurs héréditaires tels que les antécédents personnels ou familiaux du cancer du sein, de l'ovaire, de l'endomètre ou du colon. Et certains syndromes héréditaires à transmission autonome dominante tels que l'imitation du gène BRCA1 ou 2 et le syndrome de Lynch.

Les facteurs environnementaux sont représentés essentiellement par le tabac et l'antécédent d'irradiation. Sur le plan clinique, les tumeurs ovariennes peuvent être de découverte fortuite ou

suite à des complications. Mais le plus souvent, les patientes vont consulter pour un syndrome tumeur ascétique ou un syndrome endocrinique.

Le syndrome tumeur ascétique va être responsable de douleurs abdominales, une augmentation du volume de l'abdomen avec une altération de l'état général ainsi que les signes de compression. Pour le syndrome endocrinien, certaines tumeurs peuvent être masculinisantes et d'autres féminisantes. Sur le plan de l'examen physique, le plus souvent, les tumeurs ovariennes vont se présenter comme étant des masses abdominopelviennes ou simplement des masses latéro-utérines associées à de l'acide.

Sur le plan paraclinique, l'échographie abdominale et endovaginale représente l'examen clé. Elle va d'abord calculer la taille de la masse, étudier sa structure, est-ce qu'elle est liquidienne, solide ou mixte, voir les limites, la notion d'unir ou bilatéralité, étudier la paroi, la présence de septum et la présence de papilles, la présence ou non d'acide et voir la vascularisation endoplaire. Les signes en faveur de la malignité qu'on peut relever à l'échographie sont en général la structure solidoclistique de la masse, la paroi irrégulière, la présence de chorions épaisse et irrégulière, la présence de végétation qu'elle soit endo- ou exoclistique, la notion de bilatéralité et la présence d'acide.

Les marqueurs tumoraux ont essentiellement une valeur d'orientation. Pour les tumeurs épithéliales, nous utiliserons certainement le CA125 et le CA19-9. Mais pour les tumeurs non-épithéliales, l'alpha-fetoprotéine, l'HCG et l'LDH.

Ces marqueurs vont servir essentiellement pour le suivi post-thérapeutique. L'imagerie peut être complétée soit par une tomodensitométrie ou une imagerie par résonance magnétique. Ces deux dernières vont essentiellement servir à localiser exactement la tumeur, ses rapports avec les organes de voisinage, la présence ou non de carcinose péritoniale et voir s'il y a une atteinte bronchulinaire associée.

L'imagerie peut être complétée par une coloscopie, surtout lorsqu'on a un doute sur l'opérabilité de la patiente par rapport aux données de l'imagerie. Cette dernière permettra de visualiser la masse, faire un bilan d'extension complet, viscérale et péritoniale, ainsi que la stadification, et permettre de biopsier pour la confirmation histologique. Comme on l'avait souligné, les tumeurs ovariennes peuvent être découvertes à la suite de complications.

Ces complications peuvent être soit une torsion, la torsion est un début brutal en général avec des douleurs intenses associées à des nausées ou vomissements. À l'examen, on retrouve une défense avec une masse pelvienne fixée. L'infection aussi est redoutée, elle a le même tableau dans un contexte infectieux.

Les tumeurs peuvent se remplir ou peuvent y avoir des hémorragies intratumorales qui vont entraîner un tableau de péritonite aiguë. Les patientes avec un cancer de l'ovaire peuvent être

dénutries avec une altération de l'état général. Et puis ces tumeurs, lorsqu'elles sont volumineuses, peuvent comprimer la vécie entraînant des signes urinaires tels que l'uréthrohydronéphrose et la polyurie, ou des signes de compression digestif entraînant des troubles du transit et une constipation.

Lorsqu'on redoute un cancer de l'ovaire, la seule façon de le stadifier est la laparotomie. Celle-ci est basée essentiellement sur la cytologie péritoniale, la présence ou non d'atteintes péritoniales avec le taille des implants et puis la présence ou non d'atteintes ganglionnaires. Sur le plan thérapeutique, la chirurgie constitue le gold standard, le standard dans le traitement des tumeurs de l'ovaire et la laparotomie.

Cette laparotomie est en général médienne. Elle permettra à l'exploration, à réaliser des gestes d'exérés, que ce soit une gistectomie, une ovaectomie, une anexectomie, ou carrément un traitement radical avec une hystérectomie totale, avec homantectomie et curage, plus ou moins des gestes extra-pelviens, notamment sur l'étage abdominal. Pour les tumeurs bénignes, le gold standard est la cellulochirurgie.

Les traitements adjuvants tels que la chimiothérapie et la radiothérapie sont réservés essentiellement aux cancers de l'ovaire. La radiothérapie va être utilisée surtout en cas de séminome, qui sont radiosensibles, et la chimiothérapie, dans les autres cas, surtout sur les tumeurs épithéliales, où le protocole standard est l'association de cisplatine ou carboplatine avec les taxanes. Sur le plan des indications, schématiquement, pour les tumeurs bénignes, il faut privilégier le traitement conservateur, sauf si la femme est âgée, surtout par la paroscopie.

Pour les tumeurs malignes, le traitement conservateur va être réservé aux stades débutants, notamment le stade 1A, chez la femme jeune nullipare. Pour les autres cas, un traitement radical est souhaitable. Pour tous les stades avancés, le traitement est radical, avec un début de clinique chirurgical complet associé à la chimiothérapie.

Les facteurs pronostiques du cancer de l'ovaire sont essentiellement représentés par l'âge de la patiente, le volume du reliquat tumoral, le type et le grade histologique, le stade de la tumeur, et l'état général de la patiente. Après un traitement d'un cancer de l'ovaire, la surveillance est essentiellement clinique. Elle est faite tous les 3 mois pendant 2 ans, tous les 6 mois pendant 3 ans, puis tous les ans.

Le CA 125 peut être demandé tous les 6 mois, et en cas d'augmentation, on complétera par une tomodensitométrie. Le pronostic du cancer de l'ovaire est mauvais pour les stades avancés, ne dépassant pas les 15%. Pour les stades débutants, il peut atteindre 80-90% de survie à 5 ans.

Pour conclure, on peut dire que les tumeurs ovariennes regroupent des pathologies diverses. Les masses ovariennes chez la femme jeune sont les plus souvent bénignes, et le cancer de l'ovaire est à redouter chez la femme âgée. Le cancer de l'ovaire est malheureusement de mauvais pronostics, et la chirurgie reste le gold standard dans le traitement des tumeurs ovariennes.

organiques.

Je vous remercie.